



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN PROGRAM KERJA
KOMITE FARMASI DAN TERAPI
TRIWULAN I
BULAN JANUARI – MARET TAHUN
2026**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

I. SDM

Jumlah SDM bulan ini:

Jabatan	Jumlah SDM			Keterangan
	Standar	Jan-Mar	Kebutuhan	
Ketua KFT	1	1	0	Sesuai
Wakil Ketua KFT	1	1	0	Sesuai
Sekretaris KFT	1	1	0	Sesuai
Anggota KFT	-	30	0	Sesuai

Pemenuhan kualifikasi SDM

Jabatan	Pendidikan		Keterangan
	Standar	Kondisi bulan ini	
Ketua KFT : dr. Adhya Aji Pratama, Sp. PD	Dokter/Apoteker	Dokter	-
Wakil Ketua KFT : dr. Riski Bagus Suhendra, Sp. DVE	Dokter/Apoteker	Dokter	-
Sekretaris : Apt. Dita Nurul Aini, S. Farm	Dokter/Apoteker	Apoteker	-
Anggota : Dokter Spesialis, Dokter Umum, Apoteker, Tenaga Vokasi Farmasi,	Dokter spesialis, Dokter umum, Apoteker,	Dokter spesialis, Dokter umum, Apoteker,	-

II. FASILITAS

No.	Kegiatan Pokok	Keterangan
1	Ruang KFT	Pengajuan ruang KFT menggunakan ruang kosong disebelah Gudang Farmasi

III. PENGEMBANGAN PELAYANAN

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Sumber Daya Manusia	1. Pelatihan <i>medication error</i> 2. Pelatihan <i>Compounding</i> sediaan non steril, Teknik aseptis dalam pencampuran obat

		3. Pemberian informasi Antibiotik Rasional kolaborasi dengan Tim PPRA
2	Monitoring Kepatuhan Formulairum Dari Aspek Penggunaan Dan Persediaan	1. Evaluasi persediaan obat yang tersedia sesuai dengan daftar Formulairum Nasional (FORNAS) dan evaluasi peresepan non formularium 2. Evaluasi obat yang tersedia sesuai dengan daftar formulairum RS (FOR-RS) 3. Evaluasi obat non-formularium tidak ada yang di stok secara reguler 4. Evaluasi prosedur dan dokumentasi permintaan obat non-formulairum Rumah Sakit
3	Mutu dan keselamatan pasien	1. Kepatuhan penggunaan FOR-NAS 2. Kejadian kekosongan obat oleh rumah sakit 3. Angka kejadian <i>medication error</i> 4. Angka kejadian efek samping obat
4	Regulasi	1. Review Formularium Rumah Sakit 2. Penyusunan Formularium 3. Penyusunan PPAB
5	Monitoring dan Evaluasi	1. Rapat Triwulan KFT 2. Laporan Triwulan KFT

Analisis dalam hal pengembangan pelayanan :

1. Sumber daya manusia merupakan kegiatan yang berfokus pada pelatihan untuk menunjukkan upaya peningkatan kompetensi tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lain
2. Implementasi kepatuhan terhadap formularium baik dari aspek penggunaan obat dan aspek persediaan dilakukan pelaksanaan monitoring setiap hari dan akan direkap setiap 3 bulan sekali untuk dilaporkan ke ketua KFT serta dianalisis bersama anggota KFT di rapat rutin KFT.
3. Mutu dan keselamatan pasien dilakukan penginputan data oleh tim yang ditunjuk dan dilakukan setiap hari dan akan direkap setiap bulannya untuk dilaporkan ke Tim PMKP serta dianalisa pencapaian mutu sesuai indikator yang telah ditetapkan.
4. Regulasi merupakan kegiatan yang berfokus pada pendukung tata kelola farmasi yang baik dari segi formularium dan PPAB

IV. KINERJA PRODUKTIVITAS

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pencapaian dan Analisa
1	Sumber Daya Manusia	1. Pelatihan <i>medication error</i> 2. Pelatihan <i>Compounding</i> sediaan non steril, Teknik aseptis dalam pencampuran obat 3. Pemberian informasi Antibiotik Rasional	1. Belum dilaksanakan pelatihan <i>medication error</i> 2. Belum dilaksanakan pelatihan compounding sediaan non steril

		kolaborasi dengan Tim PPRA	3. Telah dilaksanakan pemberian informasi antibiotik rasional kepada perawat dan DPJP yang berkolaborasi dengan PPRA
2	Pelaksanaan monitoring terhadap kepatuhan Formularium dari aspek penggunaan obat dan aspek persediaan	Melakukan monitoring setiap hari di Instalasi Farmasi terkait 1. Evaluasi persediaan obat yang tersedia sesuai dengan daftar Formulairum Nasional (FORNAS) dan evaluasi peresepan non formularium 2. Evaluasi obat yang tersedia sesuai dengan daftar formulairum RS (FOR-RS) 3. Evaluasi obat non-formularium tidak ada yang di stok secara reguler 4. Evaluasi prosedur dan dokumentasi permintaan obat non-formulairum Rumah Sakit	- Penyusunan evaluasi berdasarkan FORNAS dilaksanakan setiap bulan - Evaluasi pelaporan permintaan non-formularium - Evaluasi form permintaan dan konsultasi kepada DPJP terkait kebutuhan obat - Pelaporan rutin selama 3 bulan (laporan triwulan)
4	Mutu dan keselamatan pasien: a. Kepatuhan penggunaan FOR-NAS b. Kejadian kekosongan obat oleh rumah sakit c. Angka kejadian <i>medication error</i> d. Angka kejadian efek samping obat	a. Melakukan audit setiap hari di rawat inap dan rawat jalan terkait : • Kejadian salah input resep • Monitoring kekosongan obat • Monitoring efek samping obat baru selama 3 bulan pertama • Monitoring pelaporan MESO b. Melakukan pelaporan terkait mutu dan keselamatan pasien ke tim PIC Mutu c. Pelaporan mutu dan keselamatan pasien dilaporkan kepada anggota KFT setiap rapat rutin 3 bulan sekali dan dilakukan pembahasan serta tindak lanjut.	- Penyusunan laporan mutu secara rutin - Terbentuk laporan triwulan
4.	Regulasi 1. Review	1. Melakukan audit dan evaluasi terhadap	1. Formularium yang sudah

Formularium Rumah Sakit	formularium sekurang-kurangnya 1 tahun sekali	dievaluasi
2. Penyusunan Formularium	2. Evaluasi dilakukan berdasarkan daftar obat baru	2. Penyusunan formula
3. Penyusunan PPAB		

V. PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING EVALUASI

5.1 MONITORING KEPATUHAN FORMULARIUM DARI ASPEK PENGGUNAAN DAN PERSEDIAAN

A. Evaluasi Obat yang tersedia sesuai Formularium Nasional (FORNAS)

Pada Triwulan I, terdapat 28 obat dengan 10 obat tidak masuk FORNAS, dan 18 obat lainnya termasuk dalam FORNAS. Sedangkan total item obat yang masuk FORNAS pada akhir tahun 2025 adalah 561 dan total item pada akhir Tahun 2025 yakni 698 item.

Evaluasi persediaan di Instalasi Farmasi terhadap FORNAS menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh obat FORNAS Triwulan I}}{\text{Jumlah seluruh obat Triwulan I}} \times 100\%$$

$$\frac{561 + 18}{698 + 28} \times 100\% = 79,75\%$$

Review Evaluasi	
Plan	1. Melakukan revuiew dan sinkronisasi perencanaan obat dengan FORNAS 2. Membuat daftar prioritas obat FORNAS 3. Melakukan monitoring rutin terhadap kesesuaian FORNAS
Do	1. Melakukan evaluasi daftar obat yang tersedia di gudang farmasi. 2. Mengidentifikasi obat yang tidak sesuai FORNAS 3. Memberikan edukasi kepada dokter terkait kepatuhan FORNAS
Study	1. Penurunan jumlah item obat non-FORNAS 2. Presentase kesesuaian obat dengan FORNAS $\geq 90\%$
Action	1. Melakukan pembatasan pengadaan obat di luar FORNAS (kecuali indikasi khusus). 2. Mengoptimalkan penggunaan e-catalog dan pengadaan obat FORNAS. 3. Menyusun kebijakan internal terkait kepatuhan FORNAS. 4. Melakukan audit dan feedback rutin kepada dokter/unit pelayanan. 5. Mengembangkan sistem early warning untuk stok obat FORNAS yang kritis. 6. Melakukan evaluasi ulang setiap bulan untuk memantau peningkatan capaian

B. Evaluasi Obat yang tersedia sesuai dengan daftar Formularium Rumah Sakit (FOR-RS)

Pada Triwulan I, seluruh item yakni 698 dan 28 obat baru, dan data pembandingan FOR-RS dengan seluruh item pada FOR-RS yakni 520. Evaluasi persediaan di Instalasi Farmasi terhadap FOR-RS menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh obat di RS Triwulan I}}{\text{Jumlah seluruh obat di FOR – RS 2025}} \times 100\%$$

$$\frac{698 + 28}{520} \times 100\% = 139,6\%$$

Review Evaluasi	
Plan	1. Melakukan review daftar obat yang tersedia dibandingkan dengan FOR-RS 2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada dokter terkait kepatuhan FOR-RS. 3. Mengoptimalkan fungsi Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dalam pengendalian formularium.
Do	1. Mengidentifikasi dan mengelompokkan obat sesuai dan tidak sesuai FOR-RS. 2. Melakukan penghentian bertahap pengadaan obat non-FOR-RS. 3. Melakukan koordinasi dengan dokter dan unit pelayanan terkait penggunaan obat. 4. Menerapkan persetujuan khusus untuk peresepan obat di luar FOR-RS. 5. Melakukan monitoring penggunaan dan pengadaan obat secara berkala.
Study	1. Terdapat kelebihan item obat sebesar 39,6% dari standar. 2. Masih banyak obat non-FOR-RS yang beredar di gudang farmasi. 3. Pengendalian formularium belum berjalan optimal.
Action	1. Melakukan penarikan bertahap atau penghabisan stok obat non-FOR-RS. 2. Memperketat sistem approval untuk pengadaan obat. 3. Melakukan revisi dan <i>update</i> FOR-RS secara berkala sesuai kebutuhan klinis. 4. Melaksanakan audit rutin kepatuhan terhadap FOR-RS. 5. Memberikan <i>feedback</i> kepada dokter/unit terkait penggunaan obat non-FOR-RS. 6. Mengembangkan sistem monitoring berbasis indikator (dashboard farmasi).

C. Tidak Ditemukan Obat Non-Formularium Yang Distok Secara Reguler

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan logistik di gudang farmasi pada Januari - Maret 2026 tidak ditemukan item non-formularium yang di stok secara reguler

D. Prosedur Permintaan Obat Non-Formularium Terdokumentasi Dengan Baik

Berdasarkan audit form permintaan dan persetujuan KFT ditemukan bahwa setiap peresepan obat non-formularium menggunakan form dan terdokumentasi dengan baik

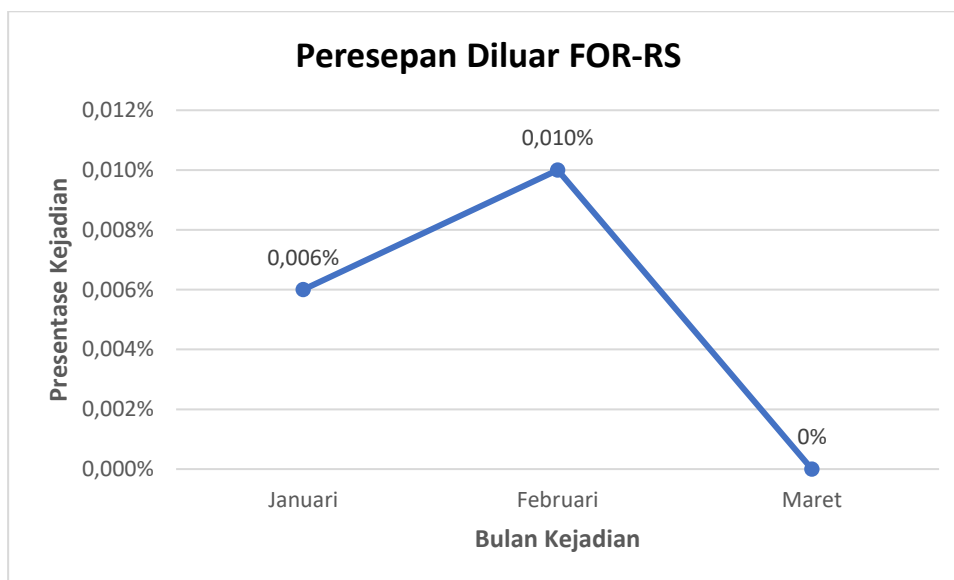
5.2 ASPEK MUTU PELAYANAN DAN KESELAMATAN PASIEN

A. Kepatuhan Penggunaan FOR-RS

Link terkait peresepan diluar FOR-RS : <https://tinyurl.com/PeresepanObatLuarFORKIT>

Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan evaluasi terkait kejadian peresepan obat non-formularium setiap bulan, dan dihasilkan data sebagai berikut :

Keterangan	Kasus		
	Januari	Februari	Maret
Jumlah resep di luar formularium	2	3	0
Jumlah seluruh resep	33042	29543	28397
% Hasil resep non formularium	0,006%	0,010%	0%
% Standar	≤ 15%	≤ 15%	≤ 15%

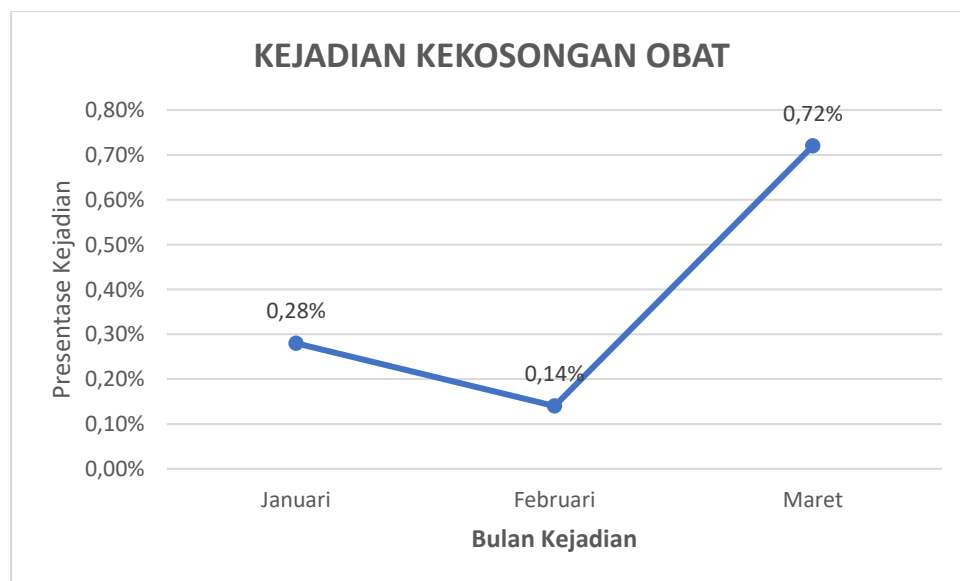


Review Evaluasi	
Plan	1. Sosialisasi For-RS terbaru ke seluruh tenaga medis 2. Penyediaan akses For-RS secara digital pad SIMRS 3. Monitoring kepatuhan pereseapan setiap bulan
Do	1. Melakukan sosialisasi formularium melalui rapat medis dan media digital 2. Membagikan formularium dalam bentuk softcopy/hardcopy 3. Koordinasi dengan dokter jika ditemukan resep non formularium 4. Mulai pencatatan dan pelaporan rutin kejadian
Study	1. Penurunan persentase pereseapan di luar formularium 2. Kepatuhan dokter terhadap formularium meningkat 3. Jumlah intervensi farmasi terkait resep non formularium
Action	Jika target tercapai : 1. Standarisasi kebijakan penggunaan formularium 2. Pertahankan monitoring berkala 3. Integrasikan ke sistem akreditasi dan mutu Jika target belum tercapai : 1. Lakukan edukasi ulang 2. Revisi For-RS sesuai kebutuhan klinis 3. Penguatan kebijakan manajemen

B. Kejadian Kekosongan Obat oleh Rumah Sakit

Link terkait kekosongan obat : <https://tinyurl.com/FormulirKekosonganRSPHS>

Keterangan	Kasus		
	Januari	Februari	Maret
Jumlah kekosongan obat	2	1	5
Jumlah seluruh item Gudang Farmasi	698	698	698
% Kejadian kekosongan obat	0,28%	0,14%	0,72%
%Standar	<2%	<2%	<2%



Review Evaluasi	
Plan	1. Penerapan metode perencanaan yang sesuai (konsumsi, ABC-VEN) 2. Penerapan safety stock dan reorder point (ROP) untuk tiap item 3. Penerapan monitoring stok minimum berkala 4. Penguatan koordinasi dengan distributor
Do	1. Melakukan sosialisasi formularium melalui rapat medis dan media digital 2. Membagikan formularium dalam bentuk softcopy/hardcopy 3. Koordinasi dengan dokter jika ditemukan resep non formularium 4. Mulai pencatatan dan pelaporan rutin kejadian
Study	1. Penurunan jumlah item yang mengalami kekosongan 2. Ketepatan waktu perencanaan dan pengadaan
Action	Jika target tercapai : 1. Standarisasi sistem perencanaan dan monitoring stok 2. Evaluasi sistem yang telah dibuat secara rutin pada triwulan pertama Jika target belum tercapai : 1. Revisi metode perencanaan

	2. Tambahkan safety stock untuk item yang fast moving, vital, dan high alert. 3. Implementasi sistem <i>early warning</i> (menggunakan stok minimum)
--	---

C. Angka Kejadian *Medication Error*

Link terkait pelaporan IKP : <https://tinyurl.com/RekapIKPFarmasi>

No	Insiden	Jumlah Kejadian		
		Januari	Februari	Maret
1	KPC (Kejadian Potensial Cedera)	-	-	2
2	KNC (Kejadian Nyaris Cedera)	-	1	-
3	KTC (Kejadian Tidak Cedera)	-	5	-
4	KTD (Kejadian Tidak Diharapkan)	-	-	-
5	Sentinel	-	-	-

Review Evaluasi	
Plan	1. Sosialisasi tentang jenis IKP dan pentingnya pelaporan. 2. Edukasi tentang prinsip <i>no blame, no punishment</i> . 3. Menyederhanakan alur dan formulir pelaporan. 4. Menyediakan akses pelaporan yang mudah (online/manual). 5. Memberikan umpan balik terhadap setiap laporan. 6. Menunjuk PIC IKP di Instalasi Farmasi. 7. Menetapkan target peningkatan jumlah laporan (terutama KNC/KPC).
Do	1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh staf farmasi. 2. Membagikan panduan singkat jenis dan alur pelaporan IKP. 3. Menyediakan formulir di area kerja atau link pelaporan. 4. PIC melakukan pendampingan jika terjadi insiden. 5. Mengumpulkan dan merekap laporan setiap bulan.
Study	1. Membandingkan jumlah laporan sebelum dan sesudah intervensi. 2. Evaluasi jenis insiden yang dilaporkan (diharapkan KNC/KPC meningkat sebagai tanda budaya pelaporan mulai terbentuk). 3. Mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi petugas. Menilai pemahaman staf melalui diskusi atau rapat evaluasi.
Action	Jika terjadi peningkatan laporan: 1. Mempertahankan program sebagai kegiatan rutin. 2. Memberikan apresiasi kepada unit/staf yang aktif melapor. 3. Melakukan analisa tren dan tindak lanjut pencegahan. 4. Pada bulan februari terjadi peningkatan pelaporan IKP, dilakukan investigasi dan pembelajaran kasus (<i>lesson learned</i>).

D. Angka Kejadian Efek Samping Obat

Link terkait pelaporan MESO :

1. <https://tinyurl.com/MonevObatBaruRSPHS>

2. <https://tinyurl.com/supervisiMESO>

Pada Triwulan I 2026 kegiatan Monitoring dan Evaluasi Obat Baru oleh KFT, terdapat total 28 obat baru pada Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

Keterangan	Kasus		
	Januari	Februari	Maret
Monitoring Efek Samping Obat Baru	0	0	0
Monitoring Efek Samping Obat Harian	2	0	0
Standar	• Pelaporan maksimal dilakukan 1 x 24 jam 0 kasus		

Review Evaluasi	
Plan	1. Sosialisasi dan pelatihan tentang MESO dan alur pengisian form MESO 2. Penunjukan PIC MESO di Instalasi Farmasi 3. Reminder rutin tiap bulan supaya masuk laporan bulanan
Do	1. Melakukan sosialisasi kepada dokter, perawat, dan apoteker 2. Implementasi pelaporan MESO (manual atau elektronik) 3. Farmasi melakukan pengumpulan dan rekap
Study	1. Membandingkan jumlah laporan sebelum dan sesudah intervensi 2. Evaluasi kelengkapan dan ketepatan waktu laporan 3. Analisa tren kejadian efek samping obat
Action	1. Melakukan perbaikan alur pelaporan agar lebih praktis 2. Memberikan feedback kepada unit terkait 3. Menambahkan sistem pelaporan berbasis digital (jika memungkinkan) 4. Menjadikan pelaporan MESO sebagai indikator mutu 5. Melakukan pelatihan ulang secara berkala 6. Memberikan reward atau apresiasi bagi unit aktif melaporkan

VI. PENCAPAIAN SASARAN BULAN JANUARI – MARET 2026

No	Aspek Kinerja	Kegiatan	Indikator	Target	Hasil	Sesuai / Tidak Sesuai
1	SDM	Pelatihan <i>medication error</i>	1. Persentase peserta yang mengikuti pelatihan dibandingkan undangan ($\geq 80\%$). 2. Persentase peserta yang lulus post-test / peningkatan skor minimal 20% dari pretest.	Terpenuhi	Belum dilakukan pelatihan	☐ Ya ☒ Tidak

			3. Penurunan angka medication error (input, dispensing, administration) setelah 3–6 bulan pasca pelatihan. 4. Kepuasan peserta terhadap 5. pelatihan ($\geq 85\%$ puas			
		Pelatihan <i>Compounding</i> sediaan non steril, Teknik aseptis dalam pencampuran obat	1. Persentase apoteker/tenaga farmasi yang mengikuti pelatihan ($\geq 80\%$ peserta wajib). 2. Peningkatan nilai uji keterampilan (<i>skill assessment</i>) minimal 20% dibanding pre-test. 3. Penurunan kesalahan dalam proses peracikan (<i>compounding error</i>) setelah pelatihan. 4. Kepatuhan terhadap SOP <i>compounding</i> dan teknik aseptis	Terpenuhi	Belum dilakukan pelatihan	☐ Ya ☒ Tidak
		Pemberian informasi Antibiotik Rasional kolaborasi dengan Tim PPRA	Kegiatan dapat berjalan sesuai dengan program kerja, staff dapat menjalankan sesuai dengan materi yang diberikan	Terpenuhi	Sudah dilakukan sosialisasi terkait PPRA	☒ Ya ☐ Tidak
2	Fasilitas	Tersedia ruang Komite Farmasi dan Terapi	Ruang Komite Farmasi dan Terapi tersendiri dan khusus	Tersedia	Tersedia ruang KFT sendiri	☒ Ya ☐ Tidak
3	Monitoring terhadap kepatuhan Formularium dari aspek penggunaan obat dan aspek	Evaluasi persediaan obat yang tersedia sesuai dengan daftar Formulairum Nasional (FORNAS)	Obat yang tersedia di RS sesuai dengan FORNAS	$\geq 90\%$	79,75%	☐ Ya ☒ Tidak
		Obat yang tersedia sesuai daftar formularium RS (FOR-RS)	Item tersedia sesuai formularium internal RS	$\geq 95\%$	139,6%	☐ Ya ☒ Tidak

	persediaan	Evaluasi obat non-formularium tidak ada yang di stok secara reguler	Tidak ada item non-formularium aktif tanpa izin khusus	0	0	☒ Ya ☐ Tidak
		Evaluasi prosedur dan dokumentasi permintaan obat non-formularium	permintaan disertai form dan disetujui KFT	100%	100%	☒ Ya ☐ Tidak
4	Mutu dan keselamatan pasien:	Kepatuhan penggunaan FORNAS	peresepan sesuai FORNAS/Formularium RS	$\geq 80-90\%$	Presentase rata-rata peresepan diluar FOR-RS Triwulan I yakni 0,005%	☒ Ya ☐ Tidak
		Kejadian kekosongan obat oleh rumah sakit	Tingkat kekosongan obat esensial	$<2\%$	Presentase rata-rata kekosongan obat Triwulan I yakni 0,38%	☒ Ya ☐ Tidak
		Angka kejadian <i>medication error</i>	Penurunan persentase/angka medication error dibanding periode sebelumnya	Terpenuhi	Terdapat 8 total IKP pada Triwulan I	☐ Ya ☒ Tidak
		Angka kejadian efek samping obat	Laporan MESO terdokumentasi 100%	Terpenuhi	Teradapat 2 laporan MESO pada Triwulan I 2026	☒ Ya ☐ Tidak
5.	Regulasi	Review Formularium Rumah Sakit	Formularium ter-review setidaknya 1 kali dalam satu tahun	Terpenuhi	Belum dilakukan review Formularium	☐ Ya ☒ Tidak
		Penyusunan	1. Formularium RS selesai disusun/ direvisi tepat	Terpenuhi	Belum dilakukan penyusun	☐ Ya ☒ Tidak

		Rormularium	waktu sesuai timeline tahunan 2. Persentase masukan dari unit/DPJP yang diakomodasi dan dievaluasi ($\geq 90\%$). 3. Dokumen formularium disetujui oleh KFT dan ditetapkan oleh Direktur RS. 4. Tingkat penyebarluasan formularium ke seluruh unit pelayanan		an Formularium 2026	
		Penyusunan PPAB	1. Dokumen PPAB tersusun lengkap sesuai standar Kemenkes/WHO dan disahkan oleh KFT. 2. Persentase DPJP yang mensosialisasikan dan menggunakan PPAB dalam praktik klinis. 3. Kepatuhan penggunaan antibiotik sesuai PPAB ($\geq 80-90\%$ pada audit antibiotik). 4. Penurunan penggunaan antibiotik broadspectrum yang tidak rasional setelah implementasi PPAB. 5. Distribusi dokumen PPAB ke seluruh unit layanan ($\geq 100\%$ unit terkait menerima)	Terpenuhi	PPAB sudah berjalan	☒ Ya ☐ Tidak

VII. ANALISIS BIAYA

No.	Sediaan Farmasi yang masuk FORKIT 2026	Harga	Bentuk Sediaan	Substitusi Sediaan paten Farmasi yang disarankan	Harga	Alasan
1.	HEXADOL GLARG	Rp. 22.600,00	BTL	MINOSEP GLARG	Rp. 21.256,00	Dari hasil kajian Komisi Farmasi dan Terapi (KFT), terdapat obat yang bisa dijadikan pertimbangan untuk penggantian untuk meningkatkan <i>cost effectiveness</i>
2.	GLIMEPIRID 1 MG – OGB DEXA	RP. 100,00	TAB	GLIMEPIRID 1 MG– HEXPHARM JAYA	Rp. 97,00	
3.	GLIMEPIRID 2 MG – OGB DEXA	RP. 200,00	TAB	GLIMEPIRID 2 MG– HEXPHARM JAYA	RP. 171,00	
4.	GLIMEPIRID 3 MG – OGB DEXA	RP. 285,00	TAB	GLIMEPIRID 3 MG– HEXPHARM JAYA	RP. 268,00	
5.	TAMIVELL	Rp. 205.128,00	VIAL	KETAGES	Rp. 61.690,00	
6.	CLOPIDOGREL 75 MG – HEXPHARM JAYA	RP. 585,00	TAB	CLOPIDOGREL 75 MG – OGB DEXA	RP. 550,00	
7.	KETOROLAC INJ – HEXPHARM JAYA	RP. 1.232,00	AMP	KETOROLAC INJ – OGB DEXA	RP. 1.250,00	
8.	ATORVASTATIN 20 MG TAB – OGB DEXA	RP. 685,00	TAB	ATORVASTATIN 20 MG TAB – HEXPHARM JAYA	RP. 540,00	
9.	CETIRIZIN TAB 10 MG – OGB NOVELL	RP. 214,00	TAB	CETIRIZIN TAB 10 MG – HEXPHARM JAYA	RP. 216,00	
10.	TRAMUS INJ	RP. 46.245,00	AMP	NOTRIXUM INJ	RP. 42.375,00	

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, kinerja pelayanan farmasi rumah sakit pada Triwulan I menunjukkan hasil yang **cukup baik namun belum optimal**, dengan rincian:

1. Aspek yang sudah sesuai

- Sosialisasi PPRA (Antibiotik Rasional) telah berjalan.
- Tidak terdapat stok rutin obat non-formularium.
- Prosedur permintaan obat non-formularium sudah sesuai (100% terdokumentasi).
- Kepatuhan persepsian terhadap formularium sangat tinggi (penyimpangan hanya 0,005%).
- Tingkat kekosongan obat rendah (0,38%)
- Pelaporan MESO sudah berjalan (100% terdokumentasi).
- Program PPAB sudah berjalan.

2. Aspek yang belum sesuai dan perlu perbaikan

- Pelatihan SDM (*medication error & compounding*) belum dilaksanakan.
- Kesesuaian obat dengan FORNAS masih rendah (79,75% < target $\geq 90\%$).
- Kesesuaian dengan FOR-RS melebihi target (139,6%) → indikasi *overstock* atau ketidakseimbangan perencanaan.
- Masih terdapat kejadian *medication error* (8 kasus IKP).
- Review dan penyusunan Formularium RS 2026 belum dilakukan.

3. Analisa Umum

Permasalahan utama terletak pada:

- Perencanaan dan pengelolaan formularium
- Penguatan kompetensi SDM
- Pengendalian mutu (*medication error*)

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)

Pasuruan, 07 April 2026

Penyusun,
Ketua Komite Farmasi dan Terapi

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD

LAMPIRAN

1. Lampiran Form Pelaporan MESO Triwulan I

a. Laporan MESO Methylprednisolon Tab 16 mg

2/8/26, 5:00 PM e-meso.pom.go.id/adreport2/print/print_detail_entry2.php?action=print&Adrid=76243&AdLang=0

ADR Case Report
Printed by # Ramadhan Rizki Putranto
Printed date # 08/02/2026

Type Report : Follow Up 1

Personal Data

Form No	Vigilow No	Vigilow Date	Vigilow By	Reporter Qualification	Type of Report	Patient Initial	Sex	Age
20260200796				Pharmacist	Report from study	A	Female	26

Primary Disease : pasien mengalami pembengkakan pada wajah khususnya pipi

Adverse Reaction

Reaction Description : 1. pasien mengalami pembengkakan pada area wajah khususnya kedua pipi

Adverse Reaction	Date Onset	End Date	Duration	Treatment of Reaction	Outcome
Face oedema	11/12/2025	15/12/2025	7	No treatment	Not recovered / not resolved

Verbal Autopsy Description :
Final Underlying Cause of Death :

Drug(s)

Drug	Substances	JKN	Medicinal treatment	Characterisation (Suspected or Concomitant)	Expected/Unexpected	Manufacture	Batch No	Pharmaceutical Form	Route of Administration	Daily Dose
METHYLPREDNISOLONE 16 MG	METHYLPREDNISOLONE	Unknown	Others	Suspected	Expected	PT HEXPHARM JAYA LABORATORIES		Tablet	PO (Per oral, oral)	16mg

Other Data

Additional Information : Keluhan saat datang ke IGD : nyeri perut, mual, muntah, kepala pusing, pipi bengkak dan merah. Riwayat Kesehatan : pasien datang dengan keluhan nyeri perut sudah 1 minggu ini semakin memberat sejak tadi malam, disertai dengan mual + muntah 5-6x hari ini, kemarin sudah periksa ke pkm dan lab juga, diberi obat belum membek, BAK kuning, belum BAB 1 minggu ini, muntah darah/kehitaman disangkal, muntah darah/pengobatan SLE di rusa sudah 3 th ini kontrol kembali tanggal 30 desember. Riwayat Penggunaan Obat : Hydroxychloroquin 1x1, methylprednisolon 2x16mg.

Laboratory Data :
:

Reporter Information

Reporter : Ramadhan Rizki Putranto
Institution : RS Prima Husada Sukorejo - Jl. Raya Surabaya - Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo - Pasu
Phone/Mobile No : 087899126172
Manufacturer Control No : 070368
Date Received by Manufacturer :

b. Laporan MESO Bamgetol Tab

ADR Case Report
Printed by # Ramadhan Rizki Putranto
Printed date # 08/02/2026

Type Report : Initial

Personal Data

Form No	Vigilow No	Vigilow Date	Vigilow By	Reporter Qualification	Type of Report	Patient Initial	Sex	Age	Eth
20260200795				Pharmacist	Report from study	ak	Female	48 Year(s)	Jawa

Primary Disease : pasien mengalami kulit melepuh di daerah mulut, dan beberapa di seluruh tubuh, kelopak mata bengkak, bola mata memerah setelah beberapa hari mengonsumsi

Adverse Reaction

Reaction Description : 1. Pasien datang dengan keluhan bibir melepuh sejak kurang lebih 3 hari terakhir. Keluhan ini disertai kedua mata tampak kemerahan dan mengeluarkan kotoran yang awal mula terlihat di daerah leher dan dada, kemudian menyebar ke lengan dan tangan kanan serta lengan kiri bagian atas. Pasien mengeluhkan rasa gatal membuka mulut dan sulit menelan, sehingga aktivitas makan dan minum menjadi terganggu.

Adverse Reaction	Date Onset	End Date	Duration	Treatment of Reaction	Outcome of Reaction	Ser
Stevens Johnson syndrome	13/01/2026	15/01/2026	2	Medical treatment	Recovering / resolving	Yes

Verbal Autopsy Description :
Final Underlying Cause of Death :

Drug(s)

Drug	Substances	JKN	Medicinal treatment	Characterisation (Suspected or Concomitant)	Expected/Unexpected	Manufacture	Batch No	Pharmaceutical Form	Route of Administration	Daily Dose	Treat
BAMGETOL 200	CARBAMAZEPINE	Unknown	Others	Suspected	Unexpected	PT MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA		Tablet	PO (Per oral, oral)	200mg(1x1/2day(s))	13/01

Other Data

Additional Information : Pasien datang dengan keluhan bibir melepuh sejak kurang lebih 3 hari terakhir. Keluhan ini disertai kedua mata tampak kemerahan dan mengeluarkan kotoran. Muncul ruam kemerahan dengan sebagian tampak keunguan dan menonjol, yang awal mula terlihat di daerah leher dan dada, kemudian menyebar ke lengan dan dada. Pasien mengeluhkan rasa gatal dan perih pada kulit tubuh dan wajah. Selain itu, pasien juga merasa nyeri saat membuka mulut dan sulit menelan, sehingga ak dari riwayat obat, pasien mengonsumsi beberapa obat secara rutin. Obat yang telah dikonsumsi lebih dari 1 bulan antara lain metoprolamide, betahistine, dan meliputi bamgetol, ibuprofen, vitamin B kompleks, captopril 25 mg, amiodipine 5 mg, diclofenac, ibuprofen, dexametason, dan amoxicillin. Pasien mendapatkan informasi indikasi obat bamgetol dari tenaga yang juga mengonsumsi bamgetol. advice dr.sp. DVE : stop obat yang dikonsumsi sebelumnya - IVFD NS 20 tpm - Inj. Methylprednisolone 62,5mg - 0 - 0 (- Prednisolone 1-2 mg/kgBB/hari) - PO Lornetidine 10 mg-Q-0 - Kompres NS 3 x 10 menit pada lesi/ruam top untuk penekanan luar - Gentamicin oint 3x3x3 pada area luka - Curosurf 6 dd glt 1 QDS top lesi mata - Minyak zaitun 2 dd ue unt pelembap

Laboratory Data :
:

Reporter Information

Reporter : Ramadhan Rizki Putranto
Institution : RS Prima Husada Sukorejo - Jl. Raya Surabaya - Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo - Pasu
Phone/Mobile No : 087899126172
Manufacturer Control No : 136744
Date Received by Manufacturer : 15/01/2026

2. Lampiran Daftar Obat Baru pada Triwulan I

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]